



THE ULTIMATE ACADEMY



RUN

GUIDE

ANTI-BLESSURE

Prévenir, détecter et soigner
les blessures du coureur

 8 Blessures

 10 Exercices

 Étirements

 Protocoles

THEULTIMATEACADEMY.FR

Sommaire

Introduction	3
Les 8 blessures du coureur — Partie 1/2	4
Les 8 blessures du coureur — Partie 2/2	5
Programme de renforcement — Partie 1	6
Programme de renforcement — Partie 2	7
Étirements essentiels	8
Gestion de la charge d'entraînement	9
Protocole PEACE & LOVE	10
Chaussures et matériel	11
Passer à l'action	12



Introduction

Courir, c'est l'une des activités les plus naturelles et accessibles qui soit. Pourtant, les statistiques sont sans appel : **près de 65% des coureurs se blessent chaque année**, souvent pour des raisons qui auraient pu être évitées avec un peu de méthode et de régularité dans la prévention.

65%

des coureurs se blessent chaque année

3×

plus lent :
l'adaptation des tendons vs muscles

10%

d'augmentation de charge maximum par semaine

2×

plus de risques avec moins de 7h de sommeil



Progression trop rapide

L'erreur la plus fréquente. Les tendons, os et articulations s'adaptent 3 fois plus lentement que les muscles. Le corps peut sembler "en forme" alors que les structures passives sont déjà en surcharge. Augmente toujours ta charge par paliers.



Manque de renforcement

Un coureur qui ne fait que courir accumule des déséquilibres musculaires dangereux. Les fessiers, tibias antérieurs et gainage sont souvent trop faibles pour protéger genoux, hanches et chevilles lors des milliers d'impacts par séance.



Récupération sous-estimée

La performance se construit pendant le repos, pas l'effort. C'est lors du sommeil que le corps répare les micro-lésions et renforce les tissus. Moins de 7h par nuit multiplie par deux le risque de blessure selon la littérature scientifique.



Équipement inadapté

Une chaussure usée ou mal adaptée crée des douleurs sur toute la chaîne cinétique : pied, cheville, genou, hanche et dos. La rotation de deux paires différentes réduit de 40% le risque de blessure d'après les études récentes.

3 RÈGLES POUR NE PLUS SE BLESSER



Écoute ton corps : une douleur qui persiste plus de 3 jours n'est jamais anodine. Mieux vaut 3 jours de repos que 3 mois d'arrêt.



Planifie ta récupération comme une séance à part entière. Elle fait partie de l'entraînement au même titre qu'un fractionné.



2 séances de renforcement par semaine suffisent pour diviser par trois le risque de blessure sur la saison.

Ce guide est le fruit d'années d'expérience sur le terrain avec des coureurs de tous niveaux. Les protocoles présentés ici sont issus des **dernières recherches en médecine du sport** et adaptés à la réalité de l'entraînement quotidien. Utilise-le comme une référence permanente : consulte la fiche de la blessure concernée dès les premiers signaux, avant que la douleur ne s'installe vraiment.

Les 8 blessures du coureur



Périostite tibiale

Syndrome de stress du tibia

SYMPTÔMES

Douleur diffuse et brûlante le long du tibia, aggravée à l'effort et au début de séance, qui peut irradier jusqu'à la cheville.

PRÉVENTION

Progression de 10% max/semaine. **Renforcement du tibialis anterior** et du mollet. Varier les surfaces, éviter le béton en début de saison.

TRAITEMENT

Repos relatif 2 semaines, glace 15 min × 3/j. Reprise progressive sur herbe ou piste. Kiné si persistance au-delà de 3 semaines.

Fréquente chez les débutants



Tendinite d'Achille

Tendinopathie du tendon calcanéen

SYMPTÔMES

Raideur matinale au talon, douleur à la palpation à 2-3 cm de l'insertion, gonflement et parfois crépitement à la mobilisation.

PRÉVENTION

Montées excentriques sur marche (protocole Alfredson), échauffement soigneux 15 min, semelles adaptées. Éviter les changements soudains de chaussures.

TRAITEMENT

Repos relatif 2 à 4 semaines, massage transverse profond, kinésithérapie précoce. Ondes de choc si chronicité avérée.

Coueurs confirmés



Syndrome de l'essuie-glace

Bandelette ilio-tibiale (BIT)

SYMPTÔMES

Douleur vive et piquante sur la face externe du genou, apparaissant toujours après 20 à 30 min d'effort, disparaissant au repos.

PRÉVENTION

Renforcement des fessiers (moyen et grand) et abducteurs. Foam roller BIT quotidien. Augmenter la cadence vers 175-180 pas/min.

TRAITEMENT

Stop dès la douleur. AINS si nécessaire, étirements spécifiques BIT, kiné pour bilan biomécanique complet et correction de la foulée.

Longue distance



Fasciite plantaire

Aponévrosite plantaire

SYMPTÔMES

Douleur intense sous le pied au lever du lit ou en début de séance, localisée au talon et à la voûte. S'atténue après 10 min, réapparaît à l'effort prolongé.

PRÉVENTION

Renforcement intrinsèque du pied (billes, serviette avec orteils), semelles si affaissement de voûte, étirements quotidiens du mollet et du fascia.

TRAITEMENT

Étirements du fascia et gastrocnémien, botte de nuit, infiltration corticoïde si chronique. Ondes de choc en dernier recours.

Route et piste

Les 8 blessures du coureur



Claquage musculaire

Déchirure de fibre ou de faisceau

SYMPTÔMES

Douleur brutale type "coup de couteau" en plein effort, contracture immédiate, hématome possible sous 24h. Impossibilité de continuer la séance.

PRÉVENTION

Échauffement progressif de 15 min minimum avant toute séance intense. Hydratation optimale, alimentation riche en protéines, récupération respectée.

TRAITEMENT

Arrêt immédiat. Protocole PEACE & LOVE (p.10). Pas de chaleur ni d'étirements les 72 premières heures. Kiné dès J3.

Séances intenses



Syndrome fémoro-patellaire

Genou du coureur

SYMPTÔMES

Douleur sous ou autour de la rotule, aggravée en descente, en montée de marches et en position assise prolongée (genou fléchi).

PRÉVENTION

Squats et fentes unilatéraux pour renforcer le vaste médial. Travail de la hanche et du contrôle du genou. Réduction temporaire du volume.

TRAITEMENT

Repos relatif, glace post-effort, kiné pour rééquilibrage musculaire, taping rotulien (Mc Connell). Éviter la descente prolongée.

Tous niveaux



Fracture de stress

Ostéopathie de contrainte

SYMPTÔMES

Douleur localisée en un point précis (tibia, métatarses ou pied), aggravée à la percussion et à la palpation directe. Douleur nocturne parfois présente.

PRÉVENTION

Apports calciques et vitamine D suffisants. Augmentation de volume très progressive. Bilan osseux conseillé si douleurs persistantes sans cause évidente.

TRAITEMENT

Arrêt complet 6 à 12 semaines selon localisation. Imagerie (IRM ou scintigraphie) indispensable pour confirmation. Reprise sous contrôle médical strict.

Kilométrage élevé



Tendinopathie de la hanche

Syndrome du psoas ou du moyen fessier

SYMPTÔMES

Douleur profonde à l'aîne ou sur la face latérale de la hanche, en montée de côte ou en début de séance. Parfois "claquement" interne à la flexion de hanche.

PRÉVENTION

Renforcement du gainage et des fessiers. Éviter les changements de dénivelé brutaux. Étirements du psoas et des rotateurs externes après chaque séance.

TRAITEMENT

Repos relatif, kiné pour massage et exercices excentrique/isométrique du psoas. Infiltration échoguidée si chronicité au-delà de 3 mois.

Trail et côtes

Programme de renforcement

2 séances/semaine suffisent pour construire une armure musculaire solide. Ces exercices ciblent les zones les plus sollicitées en course. Respecte le temps de récupération entre les séries : 60 à 90 secondes.



01

Squat unilatéral

Quadriceps · fessiers · stabilisateurs

3 × 12 reps

Debout sur une jambe, descends lentement jusqu'à 90°. Garde le genou dans l'axe du pied. Remonte en contrôlant.

Conseil : Variation avancée : squat bulgare avec pied arrière surélevé sur banc



02

Hip thrust

Grand fessier · ischio-jambiers

3 × 15 reps

Dos sur banc, pieds à plat, pousse le bassin vers le haut en contractant fort les fessiers. Pause 1 sec en haut.

Conseil : Essentiel pour prévenir toutes les blessures au genou et à la hanche



03

Mollet excentrique

Soléaire · gastrocnémien · Achille

3 × 15 lentes

Sur une marche, monte sur les deux pieds puis redescends lentement sur une seule jambe en 4 secondes.

Conseil : Prophylaxie numéro 1 contre la tendinite d'Achille — à faire chaque semaine



04

Fente marchée

Quadriceps · fessiers · soléaire

3 × 10/côté

Pas en avant, genou avant à 90°, genou arrière effleure le sol. Pousse sur le talon avant pour remonter.

Conseil : Améliore l'équilibre dynamique et la proprioception globale du coureur



05

Pont fessier

Grand fessier · core · ischios

3 × 20 reps

Allongé dos au sol, genoux fléchis à 90°, pousse le bassin vers le haut. Tiens 2 sec en haut, redescends lentement.

Conseil : Version avancée : une jambe tendue à l'horizontale, alternance gauche/droite

Programme de renforcement



06

Clam shell

Moyen fessier · abducteurs

3 × 20/côté

Allongé sur le côté, hanches fléchies à 60°. Ouvre et ferme le genou supérieur comme une palourde. Lent et contrôlé.

Conseil : Idéal pour prévenir le syndrome de l'essuie-glace et les douleurs de hanche



07

Planche latérale

Obliques · carré des lombes · abducteurs

3 × 30 sec

Sur l'avant-bras, corps aligné des pieds à la tête. Hanches hautes, ne laisse pas la hanche s'affaisser.

Conseil : Progression : planche latérale avec levée de jambe supérieure, 15 reps



08

Tibialis raise

Tibial antérieur · extenseurs des orteils

3 × 20 reps

Dos contre un mur, talons à 30 cm du mur. Lève la pointe des pieds vers le haut en gardant les talons au sol. Mouvement lent et contrôlé.

Conseil : Prévention directe et très efficace contre la périostite tibiale



09

Copenhagen plank

Adducteurs · core · stabilisateurs

3 × 20 sec

Planche latérale avec pied supérieur posé sur un banc. Soulève la hanche inférieure pour créer un pont. Respire normalement.

Conseil : Un des meilleurs exercices de prévention toutes catégories confondues



10

Chaise au mur

Quadriceps · genou · isométrique

3 × 45 sec

Dos contre le mur, genoux à 90°. Tiens la position sans bouger. La brûlure dans les quadriceps est tout à fait normale.

Conseil : Excellent pour renforcer la rotule et prévenir le syndrome fémoro-patellaire

Étirements essentiels

Les étirements doivent être pratiqués **après l'effort uniquement**, jamais à froid avant de courir. Tiens chaque position sans rebonds, en respirant lentement et régulièrement. La régularité quotidienne prime sur l'intensité.



Quadriceps

Face avant de la cuisse

30 sec × 3

Debout sur une jambe, saisir le pied derrière et ramener le talon vers la fesse. Garde le genou pointé vers le bas et le bassin neutre. Respire lentement et ne bascule pas le buste en avant.

Note du coach

Essentiel après les séances de fractionné ou de côtes.
Négligé par la plupart des coureurs.



Ischio-jambiers

Face arrière de la cuisse

30 sec × 3

Assis au sol, jambe tendue devant toi, dos bien droit. Penche le buste vers l'avant depuis les hanches (pas depuis le dos). Maintiens sans rebond, expire à chaque relâchement.

Note du coach

Ne jamais faire en force. Un ischio souple = moins de risques de claquage et meilleure foulée.



Mollet et Achille

Gastrocnémien · tendon calcanéen

45 sec × 3

Main contre un mur, pied arrière à plat sur le sol, genou tendu. Pousse activement le talon vers le sol tout en maintenant la hanche et le dos droits. Fais les 2 versions : genou tendu puis genou fléchi.

Note du coach

Priorité absolue pour les tendinites d'Achille. À faire chaque soir, même sans blessure.



Bandelette ilio-tibiale

Hanche externe · BIT

30 sec × 3

Debout, croise la jambe à étirer derrière l'autre. Penche le buste du côté opposé en appuyant la hanche vers l'extérieur. Lève le bras du même côté vers le plafond pour amplifier l'étirement. **Règle d'or** : Ne jamais s'étirer sur une douleur aiguë. Si une zone est douloureuse, consulte un kinésithérapeute avant de reprendre. La douleur pendant un étirement n'est pas la douleur vers la poitrine. Sens l'étirement dans la fesse droite. Respire régulièrement.

Note du coach

Indispensable si tu cours plus de 3 fois par semaine.
Combine avec foam roller sur la BIT.



Piriforme et fessier profond

Fessier profond · rotateurs externes

30 sec × 3

Allongé sur le dos, croise la cheville droite sur le genou gauche. Saisir la cuisse gauche et tire doucement vers la poitrine. Sens l'étirement dans la fesse droite. Respire régulièrement.

Note du coach

Souvent la cause cachée des



Fascia plantaire

Voûte plantaire · talon

60 sec × 2

Assis, saisir les orteils d'un pied et les tirer vers le tibia pour mettre le fascia sous tension. Maintenir 30 sec, relâcher. Masser ensuite la voûte circulairement avec une balle de tennis ou de golf.

Note du coach

À faire dès le réveil, avant le premier pas au sol. Capital pour prévenir la fasciite plantaire.

Gestion de la charge

La **surcharge chronique** est la première cause de blessure chez le coureur. Le corps s'adapte si on lui laisse le temps. La règle d'or : n'augmenter qu'un seul paramètre à la fois et planifier la récupération comme une séance à part entière.



Règle des 10%

N'augmente jamais ton volume de plus de 10% par semaine. Applique un cycle 3 semaines de charge / 1 semaine de décharge pour optimiser la surcompensation.



Signaux d'alarme

Un RPE constamment élevé, des douleurs inhabituelles ou une fatigue persistante au réveil sont des signaux d'alarme. Réduire immédiatement la charge avant d'aggraver.



Sommeil = récupération

Moins de 7h de sommeil multiplie par 2 le risque de blessure. Priorise le sommeil autant que l'entraînement : c'est pendant la nuit que le corps se renforce vraiment.



Semaine de décharge

Toutes les 3 à 4 semaines, réduis le volume de 30 à 40%. Cette décharge planifiée déclenche la surcompensation et permet les progrès durables sur la longue durée.

VARIABLES À SURVEILLER ET ÉQUILIBRER

Volume hebdomadaire		70%	+ 10% max / semaine
Intensité des séances		80%	Contrôle via fréquence cardiaque
Fréquence de séances		60%	Augmenter progressivement
Dénivelé positif		45%	Variable souvent négligée
Allure spécifique		35%	Introduire en phase finale
Récupération active		90%	Ne jamais sacrifier le repos

Comment lire ce tableau ?

Les pourcentages représentent l'importance relative de chaque variable dans l'équation charge/récupération. **Ne modifie jamais deux variables simultanément** : augmente le volume OU l'intensité, jamais les deux en même temps sous peine de surcharge.

Le cycle idéal

- ☑ **Semaines 1-3** : charge progressive +5 à +10%
- ☑ **Semaine 4** : décharge -30 à -40% du volume
- ☑ Répéter le cycle avec nouveau palier supérieur

Protocole PEACE & LOVE

Le protocole PEACE & LOVE remplace l'ancien RICE (Repos, Glace, Compression, Élévation). Il intègre les **dernières recherches en médecine du sport** pour une gestion complète et éprouvée des blessures aiguës.

P**Protection**

Limitier les activités douloureuses les 1 à 3 premiers jours. Repos relatif, sans immobilisation totale, pour éviter d'aggraver la lésion.

E**Élévation**

Élever le membre blessé au-dessus du niveau du cœur le plus souvent possible pour réduire l'enflure et accélérer le drainage lymphatique.

A**Anti-inflammatoires : non**

Dans les 72 premières heures, ils freinent l'inflammation naturelle, pourtant essentielle à la cicatrisation. Les éviter sauf prescription médicale.

C**Compression**

Bandage compressif pour limiter l'oedème et soutenir les tissus. Bien serré mais sans couper la circulation : les doigts ne doivent pas bleuir.

E**Éducation**

Comprendre sa blessure pour mieux la gérer. La douleur est un signal utile, pas un ennemi. La reprise progressive est toujours supérieure à l'arrêt total.

L**Loading progressif**

Reprendre la mise en charge dès que possible. Le mouvement contrôlé favorise la guérison et prévient la perte musculaire et de proprioception.

O**Optimisme**

L'état d'esprit positif influence directement la guérison. Les patients optimistes récupèrent plus vite et font moins de rechutes, selon la littérature scientifique.

V**Vascularisation**

Cardio non douloureux (vélo, natation, marche) pour maintenir le flux sanguin, accélérer la cicatrisation et préserver la condition physique.

E**Exercice ciblé**

Reprendre les exercices de renforcement spécifiques dès que possible. La rééducation active est toujours supérieure au repos passif prolongé.

Chaussures et matériel

Le choix de la chaussure est souvent **sous-estimé**, alors qu'il est l'un des facteurs les plus importants dans la prévention des blessures. Une chaussure inadaptée peut créer des problèmes sur toute la chaîne cinétique.

Chaussure d'entraînement daily



Amorti modéré, durabilité maximale. Pour les footings quotidiens. À renouveler tous les 600 à 800 km : les propriétés amorties disparaissent avant que la semelle ne soit usée visuellement. Base indispensable.

Chaussure de vitesse / plaquée



Carbone ou nylon rigide pour les séances intenses et les compétitions. Ne pas utiliser pour les footings quotidiens : le drop très bas et la rigidité entraînent une surcharge tendineuse avérée si l'usage est trop fréquent.

Trail et chaussure de stabilité



Drop bas et semelle adhérente pour le trail. Sur route, la chaussure de stabilité est recommandée en cas de pronation excessive confirmée par un podologue. Elle corrige le valgus sans pour autant rigidifier le pied.

Rotation de 2 à 3 paires



Alternar plusieurs paires différentes réduit de 40% le risque de blessure selon les études. Chaque modèle sollicite différemment le pied et les articulations, permettant une meilleure récupération des tissus entre les sorties.

Bilan podologique régulier



Un bilan biomécanique est conseillé tous les 2 ans ou après une blessure répétée. Des semelles orthopédiques sur-mesure peuvent corriger des déséquilibres structurels qui fragilisent l'ensemble de la chaîne cinétique du bas du corps.

PASSE À L'ACTION

Prêt à courir plus intelligent ?



Tu as maintenant toutes les clés. La prochaine étape : un plan structuré qui respecte tes capacités et te fait progresser sans te blesser.

Mes plans d'entraînement PDF



Plan 10 km

8 semaines

à partir de 14,99€



Plan 10 km

12 semaines

à partir de 14,99€



Semi-Marathon

12 semaines

à partir de 19,99€



Marathon

12 semaines

à partir de 22,99€



Marathon

16 semaines

à partir de 22,99€



Guide Anti-Blessure

Tu lis ce guide. Partage-le à un coureur qui en a besoin pour rester sur les routes le plus longtemps possible.

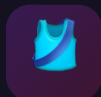
14,99€



Coaching personnalisé

Plan 100% sur-mesure, suivi hebdomadaire et messagerie directe avec ton coach Alexis Elie.

à partir de 30€/mois



Rejoins The Ultimate Academy

Déjà **70 coureurs** qui progressent et courent sans blessure. Retrouve tous les plans, le coaching et les ressources sur :

theultimateacademy.fr